

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CARROLL-TAG · ESCALA DE DETECCIÓN DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Instrumento clínico breve de cribado diagnóstico y evaluación de gravedad según criterios DSM-IV / CIE-10

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Carroll-Davidson Generalized Anxiety Disorder Screening Scale (Carroll-TAG)
Autores Originales	Bernard J. Carroll y Jonathan R. T. Davidson (2000)
Procedencia y Validación	Duke University Medical Center (EE. UU.). Validación en atención primaria española.
Tipo de Instrumento	Escala breve de cribado clínico (autoaplicada o heteroaplicada asistida)
Población Diana	Población adulta (> 18 años) en atención primaria, consultas externas y salud mental
Tiempo de Aplicación	3 a 5 minutos (12 reactivos de cribado sintomático)
Formato de Respuesta	Escala dicotómica Sí / No (con graduación de severidad en ítems nucleares)
Finalidad Clínica	Detección oportuna, cribado rápido y seguimiento de síntomas de Trastorno de Ansiedad Generalizada en contextos médicos y psiquiátricos

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) es uno de los desórdenes psiquiátricos más prevalentes y a la vez más infradiagnosticados en la medicina ambulatoria general. Los pacientes con TAG suelen consultar reiteradamente por síntomas somáticos inespecíficos (cefaleas tensionales, dolores musculoesqueléticos crónicos, dispepsias funcionales o insomnio pertinaz), ocultando el núcleo cognitivo de la afección. La escala de Carroll y Davidson fue diseñada como una herramienta de rastreo rápido estructurada directamente sobre la nosología operativa del DSM-IV.

El instrumento evalúa los tres ejes diagnósticos cardinales del TAG: a) la presencia de preocupación excesiva y desproporcionada sobre diversos sucesos cotidianos, prolongada durante un mínimo de 6 meses; b) la dificultad subjetiva manifiesta para controlar o detener dicha preocupación (sensación de pérdida de control cognitivo); y c) la manifestación de síntomas de hiperactividad autonómica y tensión motora (fatiga, inquietud psicomotriz, irritabilidad, tensión muscular e insomnio de conciliación). Su diseño agiliza la toma de decisiones clínicas evitando evaluaciones psicométricas farragosas en centros de alta demanda asistencial.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dominio Diagnóstico	Nº Ítems	Criterio Evaluado	Manifestación Clínica Típica
Preocupación Excesiva	2 ítems	Criterio A DSM-IV / CIE-10	Ansiedad persistente, desproporcionada y multifocal durante al menos 6 meses.
Incontrolabilidad	2 ítems	Criterio B DSM-IV	Incapacidad subjetiva de desconectar del pensamiento aprensivo catastrófico.
Tensión Motora y Somática	4 ítems	Criterio C (1, 2, 5)	Inquietud, tensión muscular cervical/lumbar, incapacidad para relajarse corporalmente.
Vigilancia y Fatigabilidad	4 ítems	Criterio C (3, 4, 6) e Interferencia	Irritabilidad fácil, fatiga diurna constante, sueño no reparador y deterioro social.

Estructura total: 12 ítems sindrómicos. Las respuestas afirmativas a los criterios nucleares activan la obligatoriedad de confirmación diagnóstica formal.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · CARROLL-TAG

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.86 a 0.89 en muestras de atención médica y pacientes ambulatorios psiquiátricos.
Sensibilidad y Especificidad	Con punto de corte de 6 puntos: Sensibilidad = 88.5%, Especificidad = 84.1%, Área Bajo la Curva ROC (AUC) = 0.912 frente a entrevista SCID-I para TAG.
Validez Concurrente	Correlación elevada con la Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS, $r = 0.78$), GAD-7 ($r = 0.82$) y Penn State Worry Questionnaire (PSWQ, $r = 0.74$).
Rendimiento en Cribado	Valor Predictivo Negativo del 96% en atención primaria, permitiendo descartar con alta seguridad el diagnóstico de TAG ante puntuaciones bajas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Cálculo Directo de Ítems:** Cada ítem afirmativo ("Sí") recibe 1 punto; la respuesta negativa ("No") recibe 0 puntos.
- Rango de Puntuación:** Oscila entre 0 y 12 puntos totales.
- Criterio de Inclusión Mandatorio:** Para considerar positivo el despistaje de TAG no sólo se requiere alcanzar el punto de corte numérico global, sino que debe verificarse la respuesta positiva ("Sí") a los ítems nucleares de preocupación excesiva crónica e incontrolable (Ítems 1 y 2).
- Evaluación de Síntomas Somáticos:** La presencia de 3 o más síntomas somáticos del criterio C otorga confirmación clínica a la sospecha diagnóstica.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación	Estratificación	Probabilidad TAG	Directriz Terapéutica y de Seguimiento
0 a 3 puntos	Ansiedad Mínima	Baja (< 5%)	Ausencia de sintomatología clínica. No requiere intervención.
4 a 5 puntos	Ansiedad Leve	Intermedia (20%)	Síntomas ansiosos subsindrómicos o adaptativos. Seguimiento clínico preventivo.
6 a 8 puntos	Posible TAG Moderado	Alta (75% a 85%)	Cribado Positivo. Requiere confirmación clínica y abordaje TCC / farmacológico.
9 a 12 puntos	Alta Probabilidad Severo	Muy Alta (> 90%)	Cuadro sindrómico pleno con marcado compromiso funcional y somático.

ALERTA DE PUNTO DE CORTE CLÍNICO (CARROLL-TAG ≥ 6): Un valor total de 6 o superior posee un rendimiento óptimo como umbral de derivación o tratamiento en atención primaria. Debe distinguirse del trastorno de pánico (crisis paroxísticas agudas) y del trastorno depresivo mayor concurrente mediante exploración complementaria sistemática.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · CARROLL-TAG

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Aplicación en Consulta de Medicina Familiar o Salud Mental: Aplicar ante consultas repetidas por tensión muscular, cefaleas o insomnio de causas no filiadas.

Paso 2: Evaluación del Umbral de Corte:

- **Si Total < 6:** Ansiedad adaptativa o somatización menor. Información tranquilizadora, higiene del sueño y pautas de relajación diafragmática.
- **Si Total $\geq$ 6 con Criterios A y B afirmativos:** Iniciar protocolo formal de manejo de TAG:
 1. Descartar hipertiroidismo, arritmias cardíacas o consumo abusivo de cafeína/estimulantes.
 2. Iniciar Psicoterapia Cognitivo-Conductual focalizada en preocupación patológica (intolerancia a la incertidumbre) o tratamiento con ISRS/IRSN (sertralina, escitalopram, venlafaxina).
 3. Evitar pautas prolongadas de benzodiacepinas más allá de 2 a 4 semanas para prevenir dependencia física.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 42 años, administrativo en empresa de logística, acude a atención primaria derivado por el servicio de cardiología tras descartarse patología coronaria tras múltiples episodios de opresión torácica y palpitaciones.

Evaluación Psicométrica Inicial: Carroll-TAG = 10 / 12 puntos (Positivo para TAG Severo).

- Responde afirmativamente a preocupación constante (“vivo angustiado pensando que despedirán a mi equipo o que mis hijos enfermarán”), incapacidad para relajarse, tensión en trapecios y bruxismo.
- Informa de fatiga matutina crónica y despertares precoces desde hace más de 9 meses.

Abordaje Terapéutico: Se confirmó el diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Generalizada según DSM-5. Se pautó sertralina a dosis de 50 mg/día (titulada a 100 mg/día tras dos semanas) combinada con psicoterapia cognitivo-conductual (entrenamiento en resolución de problemas, exposición a la incertidumbre y relajación muscular progresiva de Jacobson). A las 8 semanas de tratamiento, la puntuación en la Carroll-TAG se redujo a 3 puntos, desapareciendo las quejas torácicas somáticas y recuperando un patrón de sueño estructurado.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CLÍNICAS DE SEGURIDAD

- Alto riesgo de abuso de alcohol o ansiolíticos como estrategia de automedicación sedante de la tensión somática crónica.
- La comorbilidad con depresión mayor es de hasta el 60%; evaluar sistemáticamente riesgo suicida ante fatiga severa y anhedonia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Trastorno de Pánico:** La ansiedad es paroxística e inesperada en crisis agudas circunscritas, a diferencia de la angustia continua y flotante del TAG.
- **Causas Médicas:** Feocromocitoma, hipertiroidismo, síndrome de abstinencia de alcohol o hipoglucemia.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Carroll, B. J., & Davidson, J. R. T. (2000). The Carroll-Davidson Generalized Anxiety Disorder (GAD) Screening Scale: Development and validation in primary care. *Journal of Clinical Psychiatry*, 61(Suppl 11), 34–41.
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Bobes, J., Bulbena, A., Luque, A., Dal-Ré, R., Ballesteros, J., & Ibarra, N. (2004). Evaluación de la comorbilidad ansioso-depresiva en atención primaria. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 32(3), 147–155.